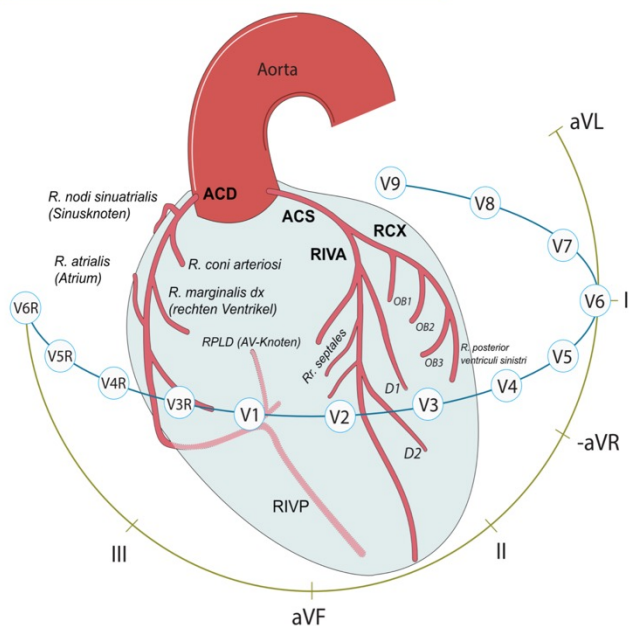


EKG-Monitoring - Elektrodenposition



		
Left circumflex artery, LCX = RCX, Ramus circumflexus		
Left anterior descending artery, LAD = RIVA, Ramus interventricularis anterior		
Left main coronary artery, LMCA = ACS, Arteria coronaria sinistra		
Right coronary artery, RCA = ACD, Arteria coronaria dextra		

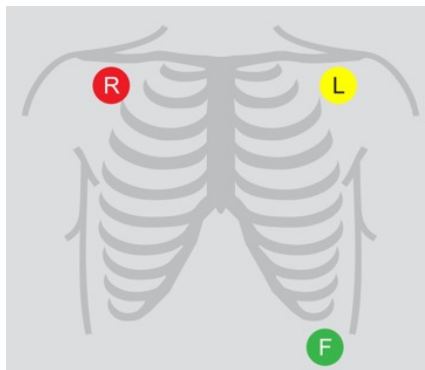
Versorgungsbereich	Mögliche Ableitungen
Vorderwand LAD	V1, V2, V3, V4
Seitenwand LAD/RCX	I, aVL, V5, V6
Hinterwand RCA (RCX)	II, III, aVF (V7, V8, V9)

Empfehlung:

Bei möglicher kardialer Ischämie mindestens zwei Ableitungen monitieren, sinnvoll sind

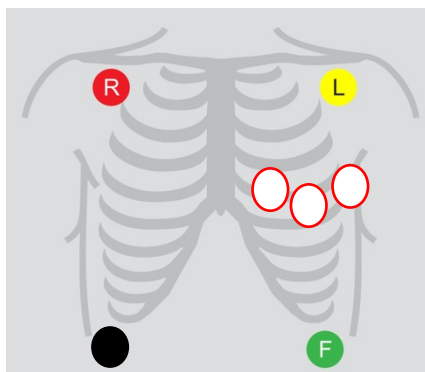
II + V5
II + V3 oder V4

II sensitiv für Arrhythmien, Vx für Ischämien



3-polige Positionierung

Ableitungen I, II und III verfügbar



5-polige Positionierung

Ableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF,
sowie - je nach Position der weißen
Elektrode - Brustwandableitung
verfügbar (im Bild: V3, V4, V5)

Elektroden alle 24-48 h austauschen!



[Thema]

Quellen

S3-LL Hämodynamisches Monitoring und Herz-Kreislauf
(12/2017);

Larsen R.: Überwachung des Intensivpatienten. Anästhesie
und Intensivmedizin für die Fachpflege. 2016 Jun 14:578-99

Gebrauchsanweisung „M 540“ Fa. Dräger

ekgecho.de/thema/koronararterien-anatomie-physiologie-ekg/